专题串联·消化系统恶性肿瘤概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）肿瘤的异型性 ①

肿瘤组织与其来源的**正常组织存在差异**：异型性**大**→分化程度**低**→恶性度**高**

①结构异型性：组织结构在**空间排列**方式不同

②细胞异型性：通常细胞体积异常和多形性，核大和多形性，核深染，核仁大而明显，**核分裂象多**，可有**病理性核分裂象**（如不对称核分裂）

癌组织长得快,DNA丰富

肝硬化是癌前病变,但是假小叶内无异性增生的肝细胞

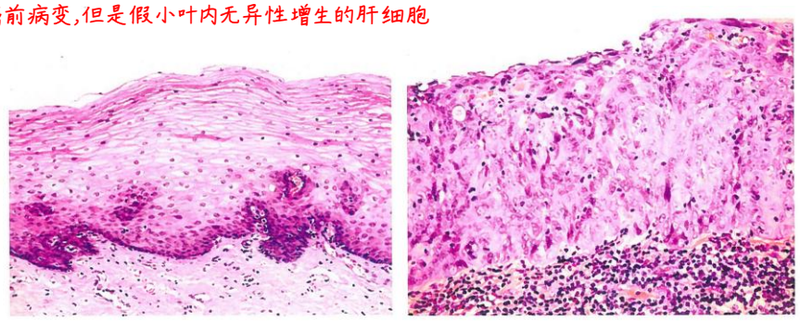


图6-2　正常鳞状上皮和鳞状细胞原位癌的比较

食管的正常鳞状上皮(左图)和鳞状细胞原位癌(右图)的比较。注意后者的结构异型性和细胞异型性均很显著,包括极性紊乱,核大、深染,核质比例增高,核分裂增多

（二）癌的转移

①抓规律：**癌最早最常见多为淋巴转移**

②记特殊：**绒癌、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移**

没有肿瘤间质、血管,直接泡在母体血管里面

先泡水溶 C

（三）消化系统恶性肿瘤的病理类型

1.中晚期大体/肉眼类型 ②

（基本类型均为蕈伞、溃疡、浸润）　蕈伞　溃疡　浸润　浸润：纤维少(软软的):髓质型；纤维多(又硬还会收缩):缩窄/硬化型

食管癌	溃疡型、蕈伞/隆起型、髓质型（**最多见**）、缩窄/硬化型 （浸润包括纤维组织少的髓质型-软软的、纤维组织多的缩窄型-硬硬的）
胃癌	溃疡型（**最多见**）、息肉/蕈伞/结节蕈伞型、浸润型（可致革囊胃）没有隆起型(是早期胃癌)
大肠癌	溃疡型（**最多见**）、隆起/息肉/蕈伞型、浸润型
肝细胞癌	单结节型、多结节型（**最多见**）、弥漫型、巨块型

① 串联：

异型性是病理学的经典概念。可见于肿瘤和某些癌前病变。

例如萎缩性胃炎可出现异型增生(Ⅱb型腺上皮化生),但肝硬化无异型增生(但是是癌前病变)。

常见干扰选项为慢支炎没有异型增生,没有纤维素样坏死,有纤维化。

② 理顺知识点：

当肿瘤向管腔面凸起时,称之为息肉型/蕈伞型/隆起型。胃肠道肿瘤,息肉多见,而食管息肉少见,故食管癌的分型中没有息肉型。

胃癌的早期分型中已经使用了“隆起型”的说法,所以,中晚期胃癌的分型中没有隆起型。

注意辨析不同名词,考试会混淆选项考察。

2.最多见的组织学类型 本身是什么上皮,最常见的就是什么类型
消化道一头一尾是鳞状上皮:口腔食管和肛门,最常见的就是鳞癌

①食管癌：鳞癌（但 Barrett 食管导致食管腺癌）
食管下段鳞状上皮被柱状上皮取代

②胃癌、肠癌、胰腺癌（导管腺癌）、胆囊癌、胆管癌：腺癌

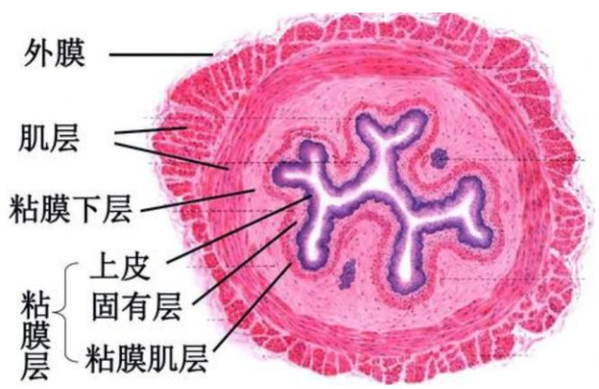
③原发性肝癌：肝细胞癌

④阑尾癌：类癌 源自嗜银细胞

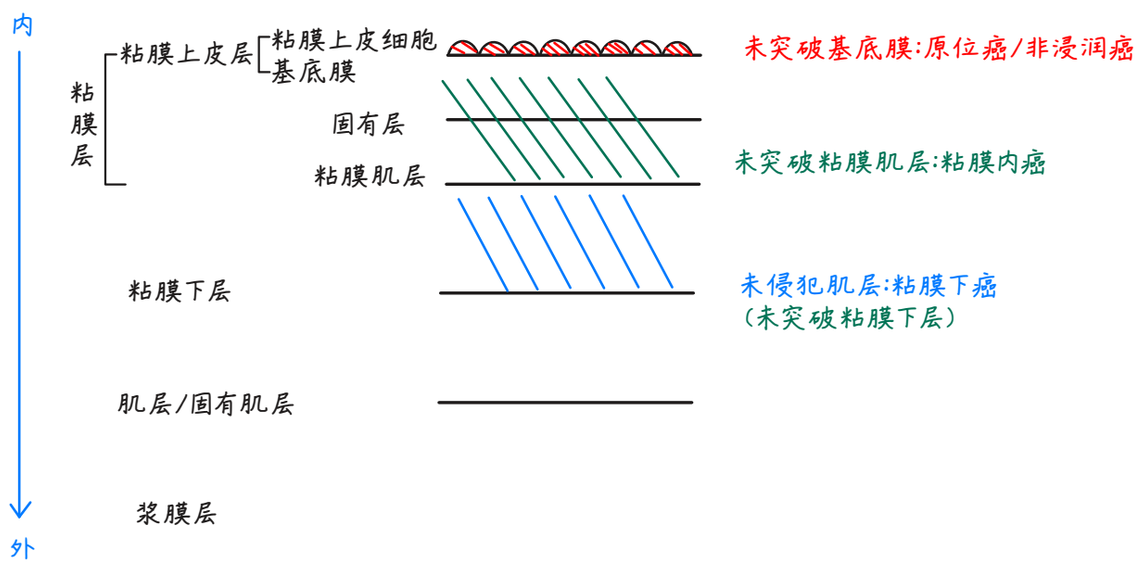
③

③ 理顺知识点:
胃肠道肿瘤的组织学类型与其本身被覆上皮类型相关。
即消化道的"一头一尾",即口腔、食管与肛门,与摩擦有关,本身被覆鳞状上皮,故食管癌的最常见组织学类型为鳞癌;
胃肠道本身被覆腺上皮,故胃肠道肿瘤多为腺癌。

（四）消化道基本的组胚层次



④



④ 理顺知识点:
特别注意胃肠道肿瘤的分期,看的是肿瘤浸润的深度,而不是肿瘤直径的大小。若肿瘤未突破基底膜,称为原位癌。若肿瘤局限于粘膜肌层,称为粘膜内癌。若肿瘤未侵犯固有肌层(即未突破粘膜下层),称为粘膜下癌。

原位癌、粘膜内癌、粘膜下癌,统称为早期癌。若侵犯肌层/固有肌层,则称为进展期癌。

VS 泌尿道粘膜与消化道粘膜的区别:
泌尿道粘膜无粘膜肌层,且膀胱三角区域无粘膜下层（于泌尿外科继续学习）